Клинические рекомендации

Абсцесс, фурункул и карбункул носа

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J34.0** — Абсцесс, фурункул и карбункул носа
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.10.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/956_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология 4

2.3 Патогенез 4

2.4 Классификация 4

2.5 Клиническая картина 5

2.6 Анамнез 5

3. Диагностика 6

3.1 Осмотр и передняя риноскопия 6

3.2 Признаки внутричерепных осложнений (оценивают при каждом осмотре) 6

3.3 Компьютерная томография головного мозга с контрастированием 7

3.4 Консультации специалистов 7

3.5 Общий анализ крови 7

3.6 Биохимический анализ крови 8

3.7 Коагулограмма 8

3.8 Бактериологическое исследование гнойного отделяемого 8

4. Лечение 8

4.1 Стадия инфильтрации: консервативное лечение 9

4.2 Системная антибактериальная терапия (все пациенты) 11

4.3 Стадия абсцедирования, карбункул, абсцесс: хирургическое лечение 13

4.4 Осложнённое течение: антикоагулянтная терапия 13

4.5 Стадия разрешения 13

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 13

5.1 Рецидивирующее течение 13

5.2 Профилактика 14
5.3 Показания к госпитализации 14
6. Источник и актуальность 14
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 15

1. Основные положения

- Лечение по стадиям:
  1. стадия инфильтрации: консервативное лечение;
  2. абсцедирование и карбункул: вскрытие и дренирование гнойника без прекращения консервативной терапии.
- При фурункуле, карбункуле и абсцессе носа во всех случаях необходима системная антибактериальная терапия, направленная на санацию очага инфекции и профилактику осложнений.
- При каждом осмотре исключают признаки внутричерепных осложнений:
  1. синдром системной воспалительной реакции;
  2. неврологическая симптоматика;
  3. офтальмологическая симптоматика;
  4. тромбоз угловой вены и кавернозного синуса.
- Признаки возможного тромбоза кавернозного синуса:
  1. лихорадка;
  2. головная боль;
  3. хемоз;
  4. экзофтальм;
  5. поражение III, IV, V и VI пар черепных нервов.

  В этом случае необходима компьютерная томография (КТ) головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием.
- Госпитализация:
  1. дети: во всех случаях, в круглосуточный оториноларингологический стационар;
  2. взрослые в стадии инфильтрации могут лечиться амбулаторно.
- Массаж области носа и выдавливание содержимого фурункула противопоказаны.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

1. фурункул носа: острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула и сальной железы на кончике или крыльях носа, в преддверии носа или в области дна носа у верхней губы;
2. карбункул носа: гнойно-некротическое воспаление нескольких волосяных фолликулов и сальных желёз с распространением вглубь и по поверхности, с обширными некрозами кожи и подкожной клетчатки;
3. абсцесс носа (абсцедирующий фурункул): скопление гноя при острой инфекции с деструкцией тканей в очаге, часто с перифокальным отёком.

2.2 Этиология

Возбудители

1. ведущий: золотистый стафилококк; резервуар инфекции: бессимптомные носители;
2. стрептококки, прежде всего бета-гемолитический стрептококк группы А.

Способствуют инфицированию фолликула

1. микротравмы кожи носа и преддверия;
2. загрязнение кожи техническими маслами и пылью при несоблюдении гигиены;
3. переохлаждение, перегревание, стресс;
4. нарушение секреторной функции кожи;
5. у детей: привычка ковырять в носу и чрезмерное сморкание.

Фурункул носа нередко является проявлением фурункулёза, то есть образования множественных фурункулов на фоне вторичного иммунодефицита при эндокринных заболеваниях, прежде всего при сахарном диабете, а также при гиповитаминозе, нарушениях питания и заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

2.3 Патогенез

Опасный треугольник: средняя зона лица, ограниченная линиями, соединяющими назион с углами рта.

Венозный отток в кавернозный синус

1. угловые вены;
2. вены орбиты;
3. крыловидное сплетение.

Вены этой системы лишены клапанов: инфекция с кожи лица, носа и околоносовых пазух распространяется гематогенно в глазницу, далее в кавернозный синус и на головной мозг.

В кавернозном синусе

1. внутренняя сонная артерия;
2. III, IV и VI пары черепных нервов;
3. первая и вторая ветви тройничного нерва;
4. к синусу прилежат гипофиз и клиновидная пазуха.

Этими анатомическими особенностями обусловлена тяжесть внутричерепных осложнений.

При снижении сопротивляемости организма и высокой вирулентности возбудителя возможна генерализация процесса: стафилококки распространяются в окружающие ткани или проникают в кровоток с развитием сепсиса. В зоне инфильтрата развивается тромбоз мелких вен, и увеличение воспалительного очага повышает угрозу распространения тромбоза.

2.4 Классификация

Стадии

1. I стадия: инфильтрация;
2. II стадия: абсцедирование.

2.5 Клиническая картина

Жалобы

1. боль в области носа;
2. головная боль;
3. слабость, снижение работоспособности;
4. повышение температуры тела до субфебрильных значений.

В общем анализе крови возможны сдвиг лейкоцитарной формулы влево и повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Фурункул может локализоваться на кончике носа, в преддверии носа, вблизи перегородки носа или в области дна носа.

Стадия инфильтрации

1. постепенно нарастающая гиперемия кожи над фурункулом;
2. локальная боль, усиливающаяся при мимических движениях и жевании;
3. нарастающая инфильтрация мягких тканей;
4. вокруг первичного очага некротическая ткань, формируется стержень фурункула;
5. на внутренней поверхности входа в нос болезненный конусовидный инфильтрат.

При благополучном течении происходит отторжение некротического стержня с выделением небольшого количества гноя, инфильтрат уменьшается, болевой синдром регрессирует, температура тела нормализуется, общее состояние улучшается.

Стадия абсцедирования

1. зона некроза увеличивается;
2. кожа над инфильтратом истончается;
3. появляется флюктуация, формируется абсцесс.

Карбункул и абсцесс носа

1. тяжёлое общее состояние, фебрильная лихорадка;
2. ощущение распирания и выраженная пульсирующая боль;
3. несколько плотных инфильтратов, сливающихся в единый увеличивающийся очаг;
4. обширная полость с гнойно-некротическим содержимым;
5. несколько отверстий на коже, из которых выделяются гной и некротизированные кровянистые массы.

У детей заболевание протекает тяжелее вследствие выраженного интоксикационного синдрома (головная боль, слабость, вялость, лихорадка). Местные изменения могут развиваться стремительнее, а обширный отёк и гиперемия верхней губы или щёчной области могут маскировать фурункул под заболевание челюстно-лицевой области.

2.6 Анамнез

В анамнезе возможны указания на переохлаждение и косметические процедуры в области наружного носа и его преддверия.

3. Диагностика

Диагноз устанавливают по трём критериям.

Жалобы

1. выраженная боль в области очага, усиливающаяся при прикосновении;
2. головная боль, недомогание;
3. повышение температуры тела.

Данные осмотра

1. гиперемия, отёк и инфильтрация мягких тканей наружного носа, преддверия носа и носо-лицевой области;
2. резкая болезненность при пальпации.

Передняя риноскопия

1. в преддверии носа у волосяного фолликула гиперемия кожи, инфильтрат и гнойный стержень в центре.

3.1 Осмотр и передняя риноскопия

Показания

1. каждый пациент с подозрением на фурункул носа: первичный осмотр оториноларинголога, врача общей практики или педиатра.

Динамика при передней риноскопии

1. начало: остиофолликулит преддверия носа, гиперемия и уплотнение в устье волосяного фолликула;
2. в течение **1–2 суток**: отёк, инфильтрация и гиперемия кожи входа в нос (стадия инфильтрации);
3. затем кожа истончается, ткани в очаге гнойно-некротически расплавляются с образованием детрита.

Наружный осмотр

1. гиперемия, отёк и болезненность в области преддверия и кончика носа;
2. прикосновение к носу и риноскопия болезненны;
3. кожа преддверия может быть покрыта толстыми жёлтыми корками;
4. при выраженном воспалении отёк распространяется на щёчную область и верхнюю губу.

Показания

1. все пациенты: основной метод инструментальной диагностики, уточнение локализации фурункула.

3.2 Признаки внутричерепных осложнений (оценивают при каждом осмотре)

При каждом осмотре необходимо оценивать наличие симптомов внутричерепных осложнений, которые объединяются в три синдрома: инфекционный, неврологический и офтальмологический.

Инфекционный синдром (синдром системной воспалительной реакции)

1. температура тела **38 °C и выше** или **36 °C и ниже**;
2. частота сердечных сокращений **90 в минуту и более**;
3. частота дыхания **более 20 в минуту**;
4. лейкоциты более 12 × 10^9/л или менее 4 × 10^9/л либо незрелых форм более 10%;
5. прокальцитонин в плазме **0,5 нг/мл и выше**.

Неврологический синдром

1. интенсивная головная боль;
2. тошнота и рвота, не связанные с приёмом пищи;
3. несистемное головокружение;
4. менингеальный синдром: светобоязнь, звукобоязнь, гиперестезия кожи, ригидность затылочных мышц; симптомы Кернига и Брудзинского, скуловой симптом Бехтерева, симптом Менделя;
5. при прогрессировании оглушение, психомоторное возбуждение, судорожный синдром.

Офтальмологический синдром

1. отёк век на стороне поражения;
2. хемоз;
3. экзофтальм;
4. болезненные тромбированные вены при пальпации век;
5. при офтальмоскопии признаки внутричерепной гипертензии.

Тромбоз угловой вены

1. резкая болезненность при пальпации;
2. интенсивная головная боль;
3. отёк лица на стороне поражения;
4. угловая вена пальпируется в виде плотного болезненного тяжа.

Тромбоз кавернозного синуса

1. на начальном этапе выраженный цианоз слизистой оболочки губ, кожи лба и носа;
2. нарастающий отёк верхней губы и щеки на стороне поражения с распространением на височную и лобную области, веки и противоположную половину лица;
3. нарушение функции глазодвигательного, блокового, отводящего и тройничного нервов вплоть до полного выпадения.

3.3 Компьютерная томография головного мозга с контрастированием

Показания

1. подозрение на тромбоз кавернозного синуса: КТ головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием.

О возможном тромбозе кавернозного синуса свидетельствуют фебрильная лихорадка, головная боль, хемоз, экзофтальм и признаки поражения III, IV, V и VI пар черепных нервов.

3.4 Консультации специалистов

Показания

1. осложнённое течение: первичные консультации офтальмолога и невролога.

При распространении воспалительного процесса на область лица целесообразна консультация челюстно-лицевого хирурга.

Алгоритм ведения пациента (приложение Б) при внутричерепных осложнениях предусматривает консультации нейрохирурга, офтальмолога и челюстно-лицевого хирурга.

> Состав консультантов при осложнениях в разных разделах рекомендации не совпадает: в разделе 2.5 и в критериях качества указаны невролог и офтальмолог, в алгоритме (приложение Б) указаны нейрохирург, офтальмолог и челюстно-лицевой хирург.

3.5 Общий анализ крови

Показания

1. все пациенты на любой стадии: оценка общего состояния и выраженности воспаления.

3.6 Биохимический анализ крови

Показания

1. выявление сахарного диабета, нарушений углеводного обмена и других состояний, способствующих развитию фурункула и утяжеляющих его течение.

1. сахарный диабет неблагоприятно влияет на частоту развития, течение и прогноз фурункула;
2. повышен уровень глюкозы: направить к эндокринологу для коррекции гликемии, выявления сахарного диабета и назначения лечебного питания;
3. изменения билирубина, креатинина, мочевины, активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ): нарушение функции печени и почек.

3.7 Коагулограмма

Показания

1. осложнённое течение;
2. сопутствующие заболевания.

3.8 Бактериологическое исследование гнойного отделяемого

Посев гнойного отделяемого на аэробную и факультативно-анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам.

Показания

1. абсцедирующий фурункул;
2. карбункул;
3. абсцесс носа.

Материал забирают из раны после вскрытия, без контакта с окружающими тканями, до начала антибактериальной терапии.

---

4. Лечение

1. метод лечения определяется стадией и характером проявлений, в том числе наличием карбункула или абсцесса;
2. при неосложнённом течении лечение преимущественно консервативное: местное и парентеральное;
3. лечение комплексное: элиминация возбудителя, купирование интоксикации, восстановление обмена веществ, повышение защитных сил организма.

По алгоритму ведения пациента (приложение Б):

1. стадия инфильтрации: консервативное лечение;
2. стадия абсцедирования: хирургическое лечение в сочетании с консервативным;
3. стадия разрешения: консультация физиотерапевта;
4. рецидив: консультации эндокринолога и аллерголога-иммунолога.

4.1 Стадия инфильтрации: консервативное лечение

Для подавления инфекции и воспаления у всех пациентов с фурункулом носа местно применяют антисептики.

1. в первые часы после появления инфильтрата: повторное смазывание пустулы 5% спиртовым раствором йода;
2. выраженное действие: четвертичные аммониевые соединения (бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний), препараты йода, хлоргексидин; допустимы у взрослых и детей;
3. повидон-йод разрешён детям **старше 28 дней**;
4. кратность обработки по выраженности воспаления, обрабатывают до разрешения инфекционного процесса;
5. в стадии инфильтрации кожу вокруг очага бережно обрабатывают 70% этанолом.

При фурункуле и карбункуле носа для санации очага местно используют мази с антибиотиками широкого спектра действия.

Мупироцин, мазь

1. взрослые: 2–3 раза в день, 5–7 дней;
2. дети с рождения: 2–3 раза в день, не более 10 дней.

Фузидовая кислота

1. взрослые: мазь или крем на кожу над фурункулом до 3–4 раз в день, 7–14 дней;
2. дети с рождения: крем 3–4 раза в день, 7–14 дней.

Диоксометилтетрагидропиримидин + хлорамфеникол, мазь: противомикробное и противовоспалительное действие

1. взрослые и дети с одного года: один раз в день до очищения раны от гнойно-некротических масс.

Для купирования воспаления и болевого синдрома при отсутствии противопоказаний рекомендуется противовоспалительная и обезболивающая терапия.

НПВП и другие анальгетики-антипиретики в монотерапии или в комбинации; выраженный эффект даёт сочетание НПВП с парацетамолом.

Метамизол натрия купирует болевой синдром у взрослых и детей, в том числе в послеоперационном периоде.

НПВП у детей

1. ибупрофен: с 3 месяцев;
2. кетопрофен: с 15 лет;
3. кетопрофен, гранулы для приготовления раствора внутрь: с 6 лет.

В амбулаторной практике от назначения метамизола натрия детям следует воздержаться; в стационаре препарат применяется только при отсутствии других анальгетиков, разрешённых к применению у детей, в связи с риском серьёзных нежелательных явлений.

Анальгетическая терапия у взрослых

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол	0,5–1 г внутривенно, инфузия в течение 15 минут	6 ч	4 г	5–7 суток
Диклофенак	75 «мл» внутримышечно (так в таблице рекомендации; по смыслу 75 мг)	12 ч	150 мг	2 суток

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Кеторолак	30 мг внутривенно или внутримышечно	8 ч	60–90 мг	2 суток
Кетопрофен	100 мг внутривенно или внутримышечно	12 ч	200 мг	не более 2 суток
Лорноксикам	8 мг внутривенно или внутримышечно	12 ч	16 мг	1–7 суток
Декскетопрофен	50 мг внутривенно или внутримышечно	8–12 ч	150 мг	2 суток
Метамизол натрия	500–1000 мг внутривенно или внутримышечно	8–12 ч	2 г	1–5 суток

> Разовая доза диклофенака в таблице 1 указана как «75 мл в/м»; исходя из смысла и суточного максимума 150 мг, речь идёт о 75 мг.

Анальгетическая терапия у детей

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол внутривенно	Инфузия в течение 15 минут: менее 10 кг — 7,5 мг/кг; 10–50 кг — 15 мг/кг; более 50 кг — 1000 мг	4 ч	Менее 10 кг — менее 30 мг/кг; 10–50 кг — менее 60 мг/кг, но не более 2 г; 33–50 кг — менее 60 мг/кг, но не более 3 г; более 50 кг — 4 г	5–7 суток
Парацетамол внутрь	С 12 лет — 0,5–1 г; 6–12 лет — 240–480 мг; 1–6 лет — 120–240 мг; от 3 месяцев до года — 72–120 мг	6 ч	С 12 лет — 4 г; 33–50 кг — менее 60 мг/кг, но не более 3 г; 10–50 кг — менее 60 мг/кг, но не более 2 г; менее 10 кг — менее 30 мг/кг	С 12 лет — 3 суток, до 12 лет — 5–7 суток
Парацетамол в ректальных суппозиториях	10–14 лет — 500 мг; 5–9 лет — 250 мг; 1–4 года — 100 мг; 3–12 месяцев — 50–100 мг	4–6 ч	Менее 60 мг/кг	До 5 суток
Ибупрофен внутрь	Старше 6 лет — 200–400 мг; 4–6 лет — 150 мг; 1–3 года — 100 мг; 3–12 месяцев — 50 мг	8 ч	12–17 лет — 1 г; 6–12 лет — 800 мг; 4–6 лет — 450 мг; 1–3 года — 300 мг; 6–12 месяцев — 200 мг; 3–6 месяцев — 150 мг	4 суток
Ибупрофен в ректальных суппозиториях	3–9 месяцев — 60 мг; 9–24 месяца — 60 мг	8 ч (3–9 месяцев), 6 ч (9–24 месяца)	3–9 месяцев — 180 мг; 9–24 месяца — 240 мг	Не более 3 суток

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Кетопрофен	С 15 лет — 100 мг внутривенно или внутримышечно	12 ч	200 мг	Не более 2 суток
Кетопрофен в гранулах для раствора внутрь	Старше 6 лет — 40 мг	8 ч	120 мг	Не более 2 суток
Метамизол натрия внутримышечно	13–14 лет — 0,8–1,8 мл (400–900 мг); 10–12 лет — 0,5–1,0 мл (250–500 мг); 7–9 лет — 0,4–1,0 мл (200–500 мг); 4–6 лет — 0,3–0,8 мл (150–400 мг); 1–3 года — 0,2–0,5 мл; 3–11 месяцев — 0,1–0,2 мл (50–100 мг)	8–12 ч	С 15 лет — 2 г; 8–14 лет — 900 мг; 4–7 лет — 600 мг; 2–3 года — 300 мг	1–5 суток

> В строке метамизола натрия таблицы 2 для детей 1–3 лет указано «0,2–0,5 мл (100–2500 мг)». При концентрации 500 мг в 1 мл, как и в соседних строках, 0,5 мл соответствуют 250 мг, следовательно, значение «2500» является опечаткой. Возраст «79 лет» в той же строке следует читать как 7–9 лет.

4.2 Системная антибактериальная терапия (все пациенты)

Всем пациентам с фурункулом, карбункулом и абсцессом носа для санации очага инфекции и предупреждения осложнений проводят системную антибактериальную терапию.

Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь

1. взрослые и дети старше 12 лет или массой более 40 кг: 1000 мг (875/125) 2 раза в сутки, 7 дней;
2. дети от 3 месяцев до 12 лет массой менее 40 кг: суспензия (400 мг амоксициллина + 57 мг клавулановой кислоты в 5 мл), 20 мг/кг в сутки;
3. новорождённые и дети до 3 месяцев: 30 мг/кг (по амоксициллину) 2 раза в день, 7–14 дней.

Цефдиторен

1. с 12 лет: 200 мг каждые 12 часов, 10 дней.

Тяжёлое или рецидивирующее течение, непереносимость бета-лактамных антибиотиков, пациенты **с 18 лет**:

1. левофлоксацин: 750 мг один раз в сутки, 7–14 дней;
2. моксифлоксацин: 400 мг один раз в сутки, 7 дней.

Цефазолин: препарат первой линии для парентерального введения

1. взрослые: 0,5 г внутривенно или внутримышечно 2 раза в день;
2. дети от месяца до 18 лет: 20–50 мг/кг в сутки в 3–4 введения;
3. длительность: 7–10 дней.

Цефтриаксон, один раз в сутки

1. взрослые и дети старше 12 лет или массой более 50 кг: 1–2 г;
2. новорождённые до 14 дней: 20–50 мг/кг, не более 50 мг/кг;
3. дети от 15 дней до 12 лет: 20–80 мг/кг;
4. длительность: 7–10 дней.

Ампициллин + сульбактам внутримышечно или внутривенно (капельно 60–80 капель в минуту или струйно медленно в течение 3–5 минут)

1. взрослые: 3–12 г в сутки в 3–4 введения в зависимости от тяжести инфекции;
2. дети: 150 мг/кг в сутки в 3–4 введения;
3. недоношенные и дети первой недели жизни: 75 мг/кг в сутки в 2 введения;
4. длительность: 5–14 дней.

Амоксициллин + клавулановая кислота внутривенно

1. взрослые и дети старше 12 лет: 1 г (по амоксициллину) 3 раза в сутки;
2. дети до 3 месяцев и массой менее 4 кг: 25/5 мг/кг каждые 8 часов, только медленной инфузией в течение 30–40 минут;
3. дети от 3 месяцев до 12 лет: 25/5 мг/кг каждые 6–8 часов в зависимости от тяжести инфекции;
4. длительность: 5–14 дней.

Клиндамицин при аллергии на бета-лактамные антибиотики

1. взрослые: парентерально 0,6–2,7 г в сутки в несколько введений;
2. дети 3–18 лет: 20–40 мг/кг в сутки в 3–4 равных приёма;
3. длительность: 7–10 дней.

Детям **младше 3 лет** противопоказан.

Парентеральные антибактериальные препараты

Препарат	Разовая доза	Кратность	Максимум в сутки	Длительность
Цефазолин	Взрослым 0,5 г; детям старше месяца 10–20 мг/кг; внутривенно или внутримышечно	2 раза в сутки	Взрослым 6 г, детям старше месяца 100 мг/кг	7–10 дней
Цефтриаксон	Взрослым 1–2 г; новорождённым до 14 дней 20–50 мг/кг; детям от 15 дней до 12 лет 20–80 мг/кг; внутривенно или внутримышечно	1 раз в сутки	Взрослым 4 г, детям 2 г	7–10 дней
Ампициллин + сульбактам	Взрослым 1–2 г; детям старше месяца 50 мг/кг; новорождённым до 14 дней 75 мг/кг; внутривенно или внутримышечно	Взрослым и детям старше месяца 3 раза, новорождённым 2 раза в сутки	Взрослым 6 г, детям 150 мг/кг	5–14 дней внутримышечно (или 5–7 дней внутривенно, затем внутримышечно до 14 дней)
Амоксициллин + клавулановая кислота	Взрослым и детям старше 12 лет 1 г внутривенно; до 12 лет 25 мг/кг внутривенно	Взрослым и детям старше 3 месяцев 3 раза, детям до 3 месяцев 2–3 раза в сутки	Взрослым и детям старше 12 лет 6 г, до 12 лет 50–75 мг/кг	5–14 дней

Препарат	Разовая доза	Кратность	Максимум в сутки	Длительность
Клиндамицин	Взрослым «0,2–0,9 мг» (так в таблице; внутримышечно не более 0,6 г, внутривенно не более 1,2 г на одно введение); детям 3–18 лет 5–10 мг/кг внутримышечно или внутривенно	3–4 раза в сутки	Взрослым 4,8 г, детям 40 мг/кг	7–10 дней

Данные раздела 3.1 и таблицы 3 не совпадают. Цефазолин детям: в тексте 20–50 мг/кг в сутки в 3–4 введения, в таблице 10–20 мг/кг 2 раза в сутки. Ампициллин с сульбактамом: в тексте взрослым до 12 г в сутки, в таблице максимальная доза 6 г; новорождённым в тексте 75 мг/кг в сутки в 2 введения, в таблице 75 мг/кг на введение 2 раза в сутки. Амоксициллин с клавулановой кислотой детям: в тексте 25 мг/кг каждые 6–8 часов (до 100 мг/кг в сутки), в таблице максимальная доза 50–75 мг/кг в сутки. Разовая доза клиндамицина взрослым в таблице указана в миллиграммах («0,2–0,9 мг»), хотя, исходя из смысла и текста (0,6–2,7 г в сутки), речь идёт о граммах.

4.3 Стадия абсцедирования, карбункул, абсцесс: хирургическое лечение

Показания к хирургическому лечению:

1. стадия абсцедирования;
2. карбункул носа.

При осложнённом течении абсцесс или карбункул носа вскрывают, чтобы эвакуировать гной и обеспечить дренирование.

Вмешательство возможно как под местной анестезией, так и под общим обезболиванием. Забор материала из раны для бактериологического исследования обязателен.

4.4 Осложнённое течение: антикоагулянтная терапия

Осложнённое течение фурункула, карбункула или абсцесса носа во всех случаях требует профилактики тромбозов антикоагулянтами прямого или непрямого действия.

Доза подбирается под контролем показателей свёртывающей системы крови.

4.5 Стадия разрешения

В стадии разрешения для ускорения выздоровления показана консультация физиотерапевта.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Рецидивирующее течение

При рецидивирующих фурункулах носа рекомендована консультация эндокринолога (у детей детского эндокринолога) для выявления причины рецидивов.

В ряде случаев целесообразна также консультация аллерголога-иммунолога.

Для профилактики рецидивов при рецидивирующем течении фурункула носа применяют бактериофаги.

Местное применение бактериофагов в комплексном лечении оправдано при устойчивости выделенных штаммов к антибиотикам, при наличии в анамнезе более двух курсов антибактериальной терапии, при непереносимости антибиотиков и при рецидивирующем течении.

5.2 Профилактика

Основа профилактики

1. личная гигиена: мытьё рук до и после еды, после туалета, поездок в транспорте и посещения общественных мест;
2. гигиена труда, средства защиты при работе в условиях запылённости и загрязнения;
3. запрет прикосновений к коже лица грязными руками, массажа болезненных участков, выдавливания фурункула и самолечения;
4. при сахарном диабете и других заболеваниях соблюдение диеты и своевременный приём препаратов;
5. обучение гигиеническим навыкам в семье, детском саду и школе.

Пациенту разъясняют

1. осторожность при косметическом уходе за лицом, включая чистку лица и бритьё;
2. при гнойничке на коже носа или верхней губы массаж и выдавливание категорически противопоказаны;
3. при отёке или гиперемии в области фурункула обращаться в оториноларингологический стационар.

Родителям

1. контролировать чистоту рук ребёнка;
2. обучать правильному туалету носа;
3. не допускать ковыряния в носу.

5.3 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. дети: установленный диагноз абсцесса, фурункула или карбункула носа (круглосуточный оториноларингологический стационар).

Взрослые в стадии инфильтрации могут лечиться у оториноларинголога амбулаторно. В большинстве случаев пациентов ведёт оториноларинголог в хирургическом стационаре.

Тактика при сопутствующих заболеваниях и рецидивирующих фурункулах в КР не указана.

> В разделе 6 фраза о пациентах с сопутствующими заболеваниями и рецидивирующими фурункулами не закончена и тактика их ведения не указана; по контексту, по-видимому, подразумевается госпитализация. Кроме того, в информации для пациента (приложение В) при отёке или гиперемии в области фурункула всем пациентам рекомендуется обращаться в оториноларингологический стационар, хотя гиперемия и отёк отмечаются уже в стадии инфильтрации, при которой взрослые, согласно разделу 6, могут получать лечение амбулаторно.

Пациента выписывают при:

1. разрешении абсцесса, фурункула или карбункула;
2. отсутствии осложнений;
3. удовлетворительном общем состоянии;
4. нормализации температуры тела.

При неосложнённом течении прогноз благоприятный. У пациентов с первичным или вторичным иммунодефицитом и с сахарным диабетом следует ожидать более тяжёлого течения и высокого риска осложнений.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Абсцесс. Фурункул носа. Карбункул носа»

Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 14.10.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2028 года
Код в рубрикаторе	956_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В таблице 1 разовая доза диклофенака указана как «75 мл».
- В таблице 2 для метамизола натрия у детей 1–3 лет указано «100–2500 мг» (объёму 0,2–0,5 мл соответствуют 100–250 мг), а возраст «79 лет» означает 7–9 лет.
- Дозы антибактериальных препаратов в тексте раздела 3.1 и в таблице 3 не совпадают: доза цефазолина у детей, максимальная доза ампициллина с сульбактамом у взрослых и его доза у новорождённых, суточная доза амоксициллина с клавулановой кислотой у детей.
- Разовая доза клиндамицина взрослым в таблице 3 указана как «0,2–0,9 мг» вместо граммов; в тексте фраза «противопоказан детям в возрасте старше до 3-х лет» искажена (по контексту имеется в виду возраст младше 3 лет).
- Состав консультантов при внутричерепных осложнениях в разделе 2.5 и в критериях качества (невролог, офтальмолог) не совпадает с алгоритмом в приложении Б (нейрохирург, офтальмолог, челюстно-лицевой хирург).
- В разделе 6 фраза о пациентах с сопутствующими заболеваниями и рецидивирующими фурункулами не закончена; рекомендация из приложения В обращаться в стационар при любом отёке или гиперемии расходится с возможностью амбулаторного лечения взрослых в стадии инфильтрации.
- Показания к хирургическому лечению сформулированы по-разному: в разделе 3.2 указаны абсцедирование и карбункул, в тезисе-рекомендации указано осложнённое течение, в критериях качества указана стадия абсцедирования.